

中药联合抗病毒治疗对艾滋病临床疗效的 Meta 分析

蔡银娇, 周兰, 陈杰

(罗定市人民医院, 广东罗定 527200)

【摘要】目的 对中药联合抗病毒治疗对艾滋病临床疗效进行 Meta 分析, 为临床用药提供进一步的依据。**方法** 通过电脑检索 2000 ~ 2020 年在中国知网、万方以及维普数据库公开发表的有关中药联合抗病毒治疗对艾滋病临床疗效的研究文献全文, 根据文献纳入和排除标准对文献进行筛选, 采用 Revman 5.3 软件进行文献质量评价和 Meta 分析。**结果** 共检索到 223 篇文献, 其中中文文献 223 篇、外文文献 0 篇。对所有文献的题目和摘要进行初步筛选, 去除重复发表的文献 122 篇, 去掉不相关文献 55 篇; 对剩余的 46 篇进行精读, 按文献纳入和排除标准, 去除不相关文献 40 篇; 排除了 8 篇研究结果相同的文章, 仅选取其中 1 篇, 共计 4 篇。最后, 将纳入的 6 篇中文文献进行 Meta 分析, 纳入文献临床疗效异质性检验, χ^2 值为 1.85, 自由度为 3, $P = 0.60 > 0.05$, $I^2 = 0\%$, 可进行固定效应模型 Meta 分析, 4 篇文献的 $OR = 7.02$, $95\%CI$ 为 $[3.47, 14.18]$, 整体效果检验 $Z = 5.43$, $P < 0.05$ 。表明中药联合抗病毒对艾滋病治疗较单纯抗病毒治疗比较差异显著。森林图结果显示, OR 的 $95\%CI$ 横线落在无效竖线右侧; 文献中 CD4 细胞变化的异质性检验结果显示, χ^2 值为 25.60, 自由度为 3, $P < 0.05$, $I^2 = 88\%$, 可进行随机效应模型 Meta 分析, 4 篇文献的 $RR = 46.94$, $95\%CI$ 为 $[38.88, 54.99]$, 整体效果检验 $Z = 11.42$, $P < 0.05$ 。对于上述两项指标绘制漏斗图, 均不对称, 存在发表偏倚风险。**结论** 中药联合抗病毒对艾滋病治疗可改善艾滋病患者的临床症状, 可增加艾滋病患者的 CD4 细胞数量, 但是纳入文献的质量不高, 存在发表偏倚, 仍需进一步扩大样本量多中心规范化进行研究, 以证实中药联合抗病毒治疗对艾滋病疗效的确定性。

【关键词】 中药; 抗病毒治疗; 艾滋病; 疗效; CD4 细胞

艾滋病是以人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引发全身免疫系统受损的感染性疾病。HIV 可破坏人体免疫系统, 以破坏 T 淋巴细胞为主, 继而造成人体免疫力下降及消失, 从而引发各种各样的机会性感染, 尤其是由于免疫功能低下而由条件性致病菌引起感染和恶性肿瘤的产生^[1-2]。由于艾滋病的发病原因十分复杂多样, 因此, 采用中药治疗艾滋病无法在短时间内获得显著效果, 因此, 需扩大样本量进行多中心的临床试验以验证^[3]。当前, 治疗艾滋病方法以高效抗逆转录病毒治疗(HAART)为主, 这种治疗方法可对艾滋病患者血浆中的病毒量进行遏制, 有助于患者免疫功能的重新建立, 然而因其不完全重新建立, 且每个患者的重建区别较大, 故不良反应的发生率也较高, 长时间使用此治疗方法极易形成耐药性, 新的抗病毒药物不良反应相对较少, 但价格昂贵, 难于长时间使用^[4-5]。本研究采用 Meta 分析方法, 评价中药联合抗病毒治疗艾滋病的疗效, 从而为临床用药提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

检索 2000 ~ 2020 年在中国知网、万方以及维普数据库公开发表的有关中药联合抗病毒治疗对艾滋病疗效的研究文献全文, 以“中药”、“抗病毒治疗”或“艾滋病”等为关键词进行文献检索, 无中英文限制。

1.1.1 纳入标准

①文献已出版; ②文献是随机临床试验, 且设置有对照组; ③文献中, 对照组对艾滋病的治疗为抗病毒治疗, 治疗组在对照组基础上加用中药治疗; ④所有文献的研究方法基本相同; ⑤所有文献的统计指标相同。

1.1.2 排除标准

①疗效评价标准不确定; ②文献不设对照组; ③试验设计存在漏洞; ④文献重复发表; ⑤有关动物或体外的实验。

1.1.3 疗效观测指标

①临床疗效; ② CD4 细胞变化。

1.2 文献质量评价

对所有纳入的文献采用 Cochrane 协作网提供的 RevMan 5.3 软件进行质量评价, 由 2 位研究者根据上述标准, 对文献进行独立检索、对其质量进行评价。通过协商达成一致意见。

1.3 统计学方法

采用 Revman 5.3 软件对纳入文献的数据行 Meta 分析。所

选计数资料用比值比(OR)表示, 计算的 95% 置信区间, 计量资料采用危险度比(RR)表示, 计算其 $95\%CI$, 做森林图, 展示研究结果的差异。通过卡方检验各项临床试验的异质性, 若 $I^2 \geq 50\%$, 选择随机效应模型进行 Meta 分析; 如果 $I^2 < 50\%$, 则选择固定效应模型行 Meta 分析。制作漏斗图, 比较分析漏斗图的对称性, 判断是否存在发表偏倚。

2 结果

2.1 纳入文献的基本资料

共计检索 223 篇文献, 其中中文文献 223 篇、外文文献 0 篇。对所有文献的题目和摘要进行初步筛选, 去除重复发表的文献 122 篇, 去掉不相关文献 55 篇; 对剩余的 46 篇进行精读, 按文献纳入和排除标准, 去除不相关文献 40 篇; 排除了 8 篇研究结果相同的文献, 仅选取其中 1 篇, 共计 4 篇。最后, 对 6 篇中文文献进行 Meta 分析。所纳入文献中, 有 1 篇文献^[5] 无风险偏移, 1 篇文献^[1] 对受试者和研究者施盲、对结局评价者施盲为高偏倚风险, 其他偏倚为未知偏倚风险; 1 篇文献^[2] 随机序列产生、分配隐藏为高偏倚风险, 对受试者和研究者施盲、对结局评价者施盲以及其他偏倚为未知偏倚风险; 1 篇文献^[3] 随机序列产生、分配隐藏、对受试者和研究者施盲以及对结局评价者施盲为未知偏倚风险; 1 篇文献^[4] 随机序列产生、分配隐藏为高偏倚风险, 对受试者和研究者施盲、对结局评价者施盲为未知危险偏倚; 1 篇文献^[6] 对受试者和研究者施盲、对结局评价者施盲以及其他偏倚为未知偏倚风险。所纳入文献的基本资料及质量评价详见表 1、图 1。

表 2: 纳入研究的文献临床疗效分布情况

作者	发表年份	临床疗效有效率 [例(%)]	
		研究组	对照组
苗慧等 ^[1]	2015	16 (72.72)	5 (16.67)
沈露等 ^[2]	2017	39 (90.70)	30 (69.77)
马英莲等 ^[5]	2010	36 (90.00)	21 (52.50)
李璇等 ^[6]	2013	30 (100.00)	29 (96.67)

2.2 中药联合抗病毒治疗对艾滋病临床疗效的 Meta 分析

根据纳入文献的异质性检验结果, χ^2 为 1.85, 自由度为 3, $P = 0.60 > 0.05$, $I^2 = 0\%$ 。可进行固定效应模型的 Meta 分析, 如图 2 所示, $OR = 7.02$, $95\%CI$ 为 $[3.47, 14.18]$, $Z = 5.43$, $P < 0.05$ 。表明中药联合抗病毒对艾滋病治疗较单纯抗病毒治疗比较差异显著。森林图结果显示, OR 的 $95\%CI$ 横线落在无效

表 1: 纳入文献的基本资料

作者	发表年份	药物		例数		疗程	统计描述
		研究组	对照组	研究组	对照组		
苗慧等 ^[1]	2015	唐草片联合 HAART	单用 HAART 治疗方案	22	30	3 个月	有
沈露等 ^[2]	2017	扶正排毒方联合高效抗逆转录病毒治疗	单纯给予高效抗逆转录病毒治疗	43	43	12 个月	有
韦秋玲等 ^[3]	2016	扶正益气汤 + AZT/TDF + 3TC + NVP/EFV 方案	AZT/TDF + 3TC + NVP/EFV 方案	40	31	3 个月	有
苏琛等 ^[4]	2019	艾复康胶囊或艾可清颗粒联合 TDF + 3TC + EFV	安慰剂联合 TDF + 3TC + EFV	121	120	72 周	有
马英莲等 ^[5]	2010	抗艾胶囊联合抗病毒治疗	抗病毒治疗	40	40	6 个月	有
李璇等 ^[6]	2013	参茸扶正胶囊联合 HAART	单独进行 HAART 治疗	30	30	6 个月	有

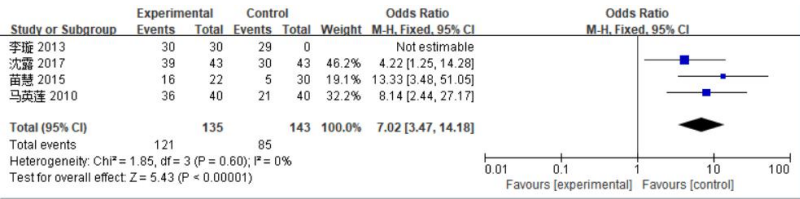


图 2: 中药联合抗病毒治疗对艾滋病临床疗效的 Meta 分析森林图

表 3: 纳入研究的文献 CD4 细胞计数疗效情况

作者	发表年份	CD4 细胞计数 [个/μl]	
		研究组	对照组
苗慧等 ^[1]	2015	339.61 ± 28.81	261.82 ± 23.52
沈露等 ^[2]	2017	330.35 ± 25.36	295.36 ± 21.53
韦秋玲等 ^[3]	2016	308.53 ± 148.52	277.07 ± 164.60
苏琛等 ^[4]	2019	394.43 ± 172.23	387.09 ± 185.84



图 1: 纳入文献的质量评价

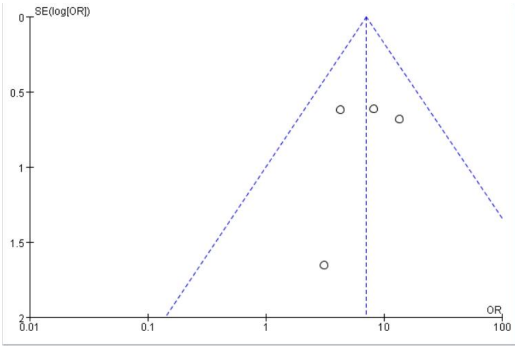


图 3: 中药联合抗病毒对艾滋病临床疗效的漏斗图

垂直线的右侧。说明中药联合抗病毒治疗能改善艾滋病患者的临床症状。漏斗图如图 3 所示。

2.3 中药联合抗病毒对艾滋病治疗 CD4 细胞变化的 Meta 分析

纳入文献异质性检验结果显示, $\chi^2 = 25.60$, 自由度 3, $P < 0.05$, $I^2 = 88\%$ 。可进行随机效应模型的 Meta 分析, 如图 4 所示, 4 篇文献的 $RR = 46.94$, $95\%CI$ 为 $[38.88, 54.99]$, 整体效果检验 $Z = 11.42$, $P < 0.05$ 。表明中药联合抗病毒对艾滋病治疗较单纯抗病毒治疗差异显著。森林图结果显示, 中药联合抗病毒对艾滋病治疗可增加艾滋病患者的 CD4 细胞数量。漏斗图见图 5。

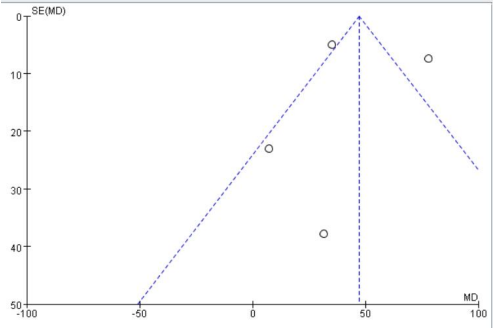


图 5: 中药联合抗病毒对艾滋病治疗 CD4 细胞变化漏斗图

3 讨论

艾滋病是一种非常严重的传染病, 中医属于疫气邪毒。艾滋病可导致体内 CD4 细胞减少, 进而导致免疫力下降^[6]。中医学认为, 艾滋病的外部病因是感染疫气邪毒, 继而使机体受损; 内部病因是损伤了正气。正气对艾滋病感染和病理过程均具有十分重要的作用^[7]。艾滋病早期出现低烧、盗汗、腹泻等症状, 直至晚期由于免疫功能低下而由条件性致病菌引起的感染, 均说明了正气从早期的抗邪作用直至晚期完全被消耗^[8]。中医学认为“正气”属于西医学“免疫功能”的范畴。中医学认为艾滋病是由内部病因和外部病因相互作用的结局。正气亏损, 邪毒侵体, 大量研究证实益气扶正法可有效控制艾滋病的病情恶化, 可调节气血津液, 清除邪气, 提升抵抗力, 维持机体免疫功能。人体感染 HIV 后, 大量破坏 CD4 细胞, 而 CD4 细胞作为免疫系统中十分关键的免疫细胞, 其具有免疫应答、杀伤和清除致病因子的作用。故 CD4 细胞可作为艾滋病患者免疫系统受损严重程度的指标^[9]。HAART 是采用 3 种或以上的抗病毒药物, 对 HIV 的复制进行较好地控制, 从而降低免疫系统受损严重程度, 遏制病情恶化, HAART 是目前治疗艾滋病十分重要的方法, 可减少 HIV 的复制, 改变 CD4 细胞数量, 减少血浆中的病毒量, 有助于患者免疫功能的重新建立, 改善患者的生存质量和免疫功能, 然而重新建立只能维持一段时间, 且体质存在个体化会导致不

参皂九味汤对子宫内异位症患者子宫动脉血流、性生活质量及血清 CA125、EMAb 的影响

黄新玉

(淮安市洪泽区人民医院药剂科, 江苏淮安 223100)

【摘要】目的 探讨参皂九味汤对子宫内异位症患者子宫动脉血流、性生活质量及血清 CA125、EMAb 的影响。**方法** 选取 2016 年 1 月~2017 年 12 月收治的 94 例子宫内异位症患者为研究对象,按照随机数字法分为观察组和对照组,各 47 例。对照组患者给予米非司酮治疗,观察组在对照组基础上加用参皂九味汤治疗。比较两组患者治疗前后生活质量评分、痛经评分、性生活质量、囊肿包块体积、子宫动脉血流动力学指标、血清 CA125、EMAb 变化情况、临床疗效以及不良反应发生情况。**结果** 观察组患者临床有效率显著高于对照组,两组患者治疗后的生活质量评分、性生活质量评分、左右子宫动脉的最大血流速度较治疗前均显著升高,痛经评分、囊肿体积及左右子宫动脉的阻力指数、搏动指数、血清 CA125 水平、EMAb 阳性率较治疗前均显著降低,且观察组的上述指标改善程度均显著优于对照组,差异均具有统计学意义($P < 0.05$)。两组患者的不良反应发生率比较差异无统计学意义($P > 0.05$)。**结论** 参皂九味汤治疗子宫内异位症疗效确切,可有效改善患者临床症状、性生活质量、子宫动脉血流动力学指标,降低血清 CA125 和 EMaB 水平,且用药安全可靠。

【关键词】 参皂九味汤; 子宫内异位症; 子宫动脉血流; 血清 CA125; EMaB

子宫内异位症是指子宫内膜组织在宫腔以外的位置生长,是妇科常见的一种疾病,好发于育龄女性,临床主要表现为月经紊乱、盆腔痛、性交不适、不孕等症状,其发病率呈逐年上升趋势,且逐渐趋于年轻化,严重影响女性的生活质量和生育

情况^[1]。目前西医治疗子宫内异位症的主要方法包括外科手术和激素类药物。但外科手术对女性子宫的损伤较大,术后复发率较高,且手术治疗的适应证存在一定的局限性,临床疗效并不理想,故患者对外科手术治疗的接受度不高^[2]。激

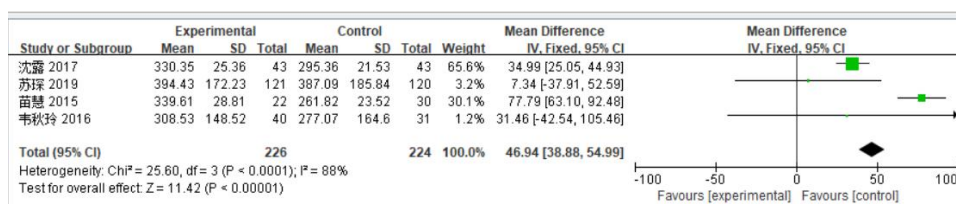


图 4: 中药联合抗病毒治疗对艾滋病治疗 CD4 细胞变化的 Meta 分析

良反应存在差异性,长时间使用会产生毒副作用和较高的耐药性,且治疗费用对于很多患者而言无法承受。通过以上 Meta 分析结果可以看出,中药联合抗病毒治疗对艾滋病治疗较单纯抗病毒治疗比较差异显著。森林图结果显示,OR 和 RR 的 95%CI 水平线落在无效垂直线的右侧。说明中药联合抗病毒治疗能改善艾滋病患者的临床症状,可增加艾滋病患者的 CD4 细胞数量。但因本次纳入的文献质量较低,对研究方法的描述不详细,由于无法判断其科学性,可能存在发表偏倚,导致本次 Meta 分析结果偏高,导致本研究结果的可靠性较差。尽管本次研究结果证实中药联合抗病毒治疗艾滋病的疗效显著,但今后需深入研究中药联合抗病毒治疗艾滋病的疗效,应进行扩大样本量、多中心进行研究,提供可靠的证据,保证此治疗方法的效果。

对上述 2 个指标绘制漏斗图,均不对称,且文献质量较差,结果表明:①所纳入的文献均为中文,可能与中药成分多,导致药理作用变得十分复杂存在一定的关系;国外发表文献较少,存在一定局限性,检索语言为中文和英文,但未发现有关中药联合抗病毒治疗艾滋病的外文文献。②纳入文献均有“随机”字样,但仅 3 篇详细描述了随机的方法,其他未明确指出随机的方法;此外,随机方法学的质量也不高。③所有纳入文献中只有一篇文献包括长期随访观察的相关内容。

为了在医学领域获得其中相关研究者和临床工作者的广泛认可,提高中医药临床试验质量是十分必要。在中药临床试验过程中,需详细描述随机序列的产生、分配的隐蔽性、受试者和研究者的盲化、结果评价者的盲化、结果数据的完整性、研究结果的选择性报告等偏倚,以尽可能减少偏倚风险^[10]。此外,中医遵循辨证论治的原则,在今后的研究可基于辨证论治纳入文

献,以获得更佳的疗效。

参考文献

- [1] 苗慧,王江蓉,陆云飞,等.复方芪术汤联合 HAART 治疗 AIDS 病人的疗效及安全性[J].中国艾滋病性病,2015,21(2):96-98.
- [2] 沈露,张金武,朱建光.扶正排毒方联合高效抗逆转录病毒疗法治疗艾滋病合并神经系统病变临床研究[J].中医学报,2017,32(3):313-317.
- [3] 韦秋玲,黄志先,韦麟,等.AIDS 病人抗病毒治疗早期结合中药干预的疗效观察[J].中国艾滋病性病,2016,22(3):207-208.
- [4] 苏琛,彭鑫,胡增,等.中药联合含依非韦仑的 HAART 方案对 HIV/AIDS 病人的中枢神经系统不良反应及疗效分析[J].中国艾滋病性病,2019,25(9):899-901.
- [5] 马英莲.中药抗艾胶囊联合抗逆转录病毒药物治疗艾滋病临床分析[J].辽宁中医药大学学报,2010,12(8):151-152.
- [6] 李璇,苏齐鉴,李益忠,等.参灵扶正胶囊联合高效抗逆转录病毒疗法治疗艾滋病病毒感染者或艾滋病患者 60 例[J].中医杂志,2013,54(19):1653-1656.
- [7] 罗龙江,高海滨,唐蓓蓓,等.中成药联合 HAART 治疗艾滋病疗效 Meta 分析[J].中医学报,2019,34(6):1352-1356.
- [8] 黄瑞,罗伟生,唐宏亮,等.中成药联合抗病毒治疗 HIV/AIDS 病人的疗效和安全性[J].中国艾滋病性病,2016,22(9):694-698.
- [9] 张扬武,罗伟生,黄瑞,等.益气扶正法联合高效抗逆转录病毒治疗对艾滋病患者免疫重建的 Meta 分析[J].辽宁中医杂志,2016,43(10):2042-2047.
- [10] 梁碧颜,王健.中医药治疗 HIV/AIDS 随机对照试验的 meta 分析[J].中医学报,2013,28(8):1095-1098.